

LECTURE CLINIQUE DU RÉCIT DE LA MALADIE : DE L'INTERTEXTUALITÉ À LA FUSION DES HORIZONS. UNE ÉTUDE DE CAS

[Catherine Draperi](#), [Philippe Spoljar](#)

Éditions Matériologiques | « PSN »

2022/2 Volume 20 | pages 75 à 90

ISSN 1639-8319

ISBN 9782373613704

Article disponible en ligne à l'adresse :

<https://www.cairn.info/revue-psn-2022-2-page-75.htm>

Distribution électronique Cairn.info pour Éditions Matériologiques.

© Éditions Matériologiques. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Lecture clinique du récit de la maladie : de l'intertextualité à la fusion des horizons. Une étude de cas

Clinical reading of the story of the disease : From intertextuality to the merging of horizons. A case study

Catherine Draperi, maître de conférences en philosophie, UFR de médecine, Centre d'Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits (EA 4289), Université de Picardie Jules-Verne, Chemin du Thil, 80000 Amiens, catherine-draperi@gmail.com.

Philippe Spoljar, maître de conférences HDR en psychologie clinique, UFR Philosophie, Sciences humaines et Sociales, Centre d'Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits (EA 4289), Université de Picardie Jules-Verne, Chemin du Thil, 80000 Amiens, philippe.spoljar@u-picardie.fr [auteur correspondant].

Résumé : Comment rendre compte de l'indicible à l'œuvre dans l'expérience traumatique de la catastrophe ? À partir d'une situation clinique rencontrée par un psychologue clinicien dans un service de réanimation, le présent article aborde la représentation mentale de la maladie organique dans son aspect textuel et intertextuel, dans l'attention au tissage des relations sémantiques qui compose toute parole. Le récit de soi emprunte des formes discursives aux traditions narratives du « racontable » qui se présentent comme des modèles de « lecture ». La textualité qui se déploie à travers ce récit adressé au clinicien inscrit la narrativité dans un *horizon d'attente* gouverné par la quête d'une réponse. De son côté, la lecture clinique de ce texte reçu repose sur un *horizon d'attente* différent, concernant ce que signifie ce récit. Du point de vue phénoménologique, le moment clinique de l'écoute et de la restitution de l'intertextualité constitutive du récit pourrait alors être à penser à travers la notion de « *fusion des horizons* » (H.-G. Gadamer), qui porterait à la parole l'intelligibilité du texte dont le clinicien doit se faire l'herméneute. La notion d'intertextualité permet de préciser l'*articulation* du psychique et de son environnement, c'est-à-dire aussi bien l'*histoire personnelle* du patient que l'ordre *collectif* de la culture ; son analyse se présente comme une voie praticable entre la *préfiguration* des événements racontés et la *refiguration* de l'histoire.

Mots-clés : clinique, interprétation, intertextualité, sémantique.

Abstract : How can we account for the inexpressible in the traumatic experience of the disaster? Based on a clinical situation encountered by a clinical psychologist in a resuscitation service, this article approaches the mental representation of organic disease in its textual and intertextual aspect, by paying attention to the weaving of the semantic relations which constitute any speech. The notion of intertextuality allows to specify the articulation of the psychic and its environment, that is both the personal history of the patient and the collective order of

culture. Self-narrative employs discursive forms of narrative traditions of the “recordable” that emerge as models of “reading”. The story is addressed to the clinician and inscribes the narrativity in a *horizon of expectation* (H.-G. Gadamer) governed by the quest for an answer. For its part, the clinical reading rests on a different horizon of expectation, concerning what this narrative means. From the phenomenological point of view, the clinical moment of listening and restitution of the narrative’s intertextuality could be approached through the notion of “fusion of horizons”. The restitution of the intertextuality appears as a way between the prefiguration of the events told and the re-figuration of the history.

Keywords: clinic, interpretation, intertextuality, semantics.

Le récit de la maladie adressé au clinicien ouvre un espace à l’expression d’une vie entravée, où l’épreuve d’une rupture est adressée comme une *demande de secours*. L’attention à cette parole est le point de départ de la médecine narrative. Animée du souci de « compléter un savoir biomédical par un savoir narratif, sensible et expérientiel », la médecine narrative décrite par Rita Charon comme un « modèle pour l’empathie, la réflexion, le professionnalisme et la confiance » [3], a été la réponse au constat de la déshumanisation des études médicales soulignée dans l’étude menée par Byron et Mary-Jo Good dans les années 1990 [10]. Dans son sillage, la médecine fondée sur les valeurs vient, de manière différente, rappeler cette évidence que la clinique doit être « centrée sur le patient » porteur de valeurs, dont la prise en compte est nécessaire pour comprendre sa situation, et guider l’interprétation de sa situation fondée sur la nosologie [7].

La conscience de l’importance des propos tenus dans la rencontre clinique doit en effet assurément être au cœur de toute clinique et par conséquent, de la formation du clinicien. L’écoute clinique, dans laquelle il s’agit toujours d’abord pour le professionnel d’*entendre* le récit d’une modification qualitative de l’existence, ne peut ni s’abandonner à une empathie dont on oublierait qu’elle est toujours elle-même positionnée, ni non plus consister dans la seule application opératoire d’une méthode. Une formalisation excessive de l’écoute courrait notamment un double risque : le premier, souligné dans un récent article de Maylis Dubasque dans les colonnes de *PSN*, serait d’articuler à l’*evidence based medicine* la *narrative based medicine* comme une *technique de traduction* par lesquelles les récits en viendraient à être schématisés, « *objectifiés par l’outil narratologique* » [5] ; le second, souligné par Juliette Ferry-Danini, serait de percevoir dans le récit une production absolument singulière, en omettant d’être attentif aux récurrences qui habitent les récits de maladies [6].

Dans un travail pionnier concernant le questionnement des médecins oncologues à propos de l’influence des interactions cliniques sur le processus théra-

peutique, Marie Jo Good mettait l'accent sur le sens des mots et leur inscription dans une histoire sociale¹. Empruntant à l'herméneutique ricœurienne la notion d'*emplotment* (la mise en intrigue), elle soulignait la directionnalité constitutive des récits qui visent à donner un sens à ce qui s'est produit et expriment la préoccupation de ce que l'histoire va devenir. C'est cette mise en mots dans une temporalisation narrative du vécu et son arrimage à un horizon sémantique hérité, qui orienteront ici notre attention à la situation clinique présentée. Cette lecture d'une situation clinique à partir de l'intertextualité du récit ne vise pas à fonder une méthode d'écoute, mais à rendre attentif à ce que mettent en jeu le récit de la maladie et l'écoute de ce récit, à et aborder d'un point de vue phénoménologique ce qui se joue dans la relation clinique.

À partir d'une situation rencontrée par l'un des auteurs, psychologue clinicien, le présent article se propose ainsi d'aborder la représentation mentale de la maladie somatique dans son aspect textuel, et plus particulièrement encore *intertextuel*, ceci dans la mesure où cette notion d'intertextualité peut permettre de préciser l'articulation du psychique et de son environnement, c'est-à-dire aussi bien l'histoire personnelle du patient que l'ordre collectif de la culture.

Cette textualité se déploie à travers un récit adressé qui se donne à lire au clinicien selon une narrativité inscrite dans un *horizon d'attente* gouverné par la perspective d'une réponse. De son côté, la lecture de ce texte adossée au lieu tiers du langage, repose également sur un *horizon d'attente*, ou encore sur une question que l'interprète adresse au récit. Du point de vue phénoménologique, le moment clinique de l'écoute et de l'appréhension de l'intertextualité constitutive du récit pourrait alors être pensé à travers la notion de la «*fusion des horizons*» [9, p. 326-329], qui restituerait l'intelligibilité du texte dont le clinicien se fait l'herméneute.

En substance, il s'agira ici d'interroger une intertextualité qui inscrit le récit dans l'héritage partagé d'histoires que le clinicien se doit d'interpréter.

Ce concept de *textualité*, de façon simple et générale :

1. souligne tout d'abord la dimension de *tissage*, tissage plus ou moins serré des liaisons sémantiques, c'est-à-dire des relations de sens, que compose toute parole ;
2. insiste ensuite sur le *lieu*, à la fois interne et externe par rapport au Moi de l'énonciateur, dans lequel se constituent et se déploient les énoncés ;

1. Cf. « Words carry meanings from the places where they have been used, and their social history is never absent from a particular usage » [4, p. 178].

3. caractérise enfin, et plus spécifiquement, l'organisation *discursive* des représentations de la maladie, de façon exemplaire ces « récits de maladies », qui sont finalement des « récits de soi malade ».

La notion de *fusion des horizons* :

1. soutient que l'interprétation du texte, en amont et en aval d'une explication de texte comme technique de déchiffrement, peut être pensée comme une *pratique de compréhension* d'un vécu rapporté qui s'énonce dans le langage et indissociablement dans l'héritage partagé de la tradition, et plus largement d'une culture ;
2. précise le lieu dans lequel le récit se présente comme un texte, dans la *rencontre herméneutique* entre l'horizon du narrateur et celui de l'interprète, différemment situés et porteurs d'attentes différentes.
3. conduit à voir en quel sens cette lecture confère au clinicien une place de *tiers*, entre l'anomalie existentielle que constitue la maladie, et la réinscription de l'irréductible singularité de l'épreuve dans le monde partagé où elle est portée au langage.

Pour étayer et illustrer ceci, nous nous appuyons sur la clinique des patients en service de réanimation, services dans lesquels une hospitalisation correspond à une épreuve toujours extrêmement violente et douloureuse – pour les patients comme pour les familles, et parfois pour les soignants – et qui se mobilise avant tout autour du traumatisme du coma et du risque vital. Il s'avère surtout que cette épreuve réanimatoire se présente *toujours* comme une expérience indicible *directement* – ceci parce qu'il n'y a par exemple pas de représentation immédiate de cette absence qu'est ce « trou (noir) » du coma – et donc que l'évocation d'une souffrance (généralement démesurée) doit chercher ses représentations entre les signifiants les plus singuliers et les symboles les plus collectifs, entre l'expression corporelle la plus abrupte et les mises en ordre culturelles les plus complexes, c'est-à-dire finalement dans une tension permanente entre le cri et le texte.

La mise en texte de la souffrance se traduit tout d'abord formellement dans la découpe, l'emprunt, l'allusion, la référence, l'allégeance à de multiples discours qui sédimentent certaines valeurs culturelles en des énoncés ordonnés et ordonnants, c'est-à-dire en déployant des formes discursives qui se présentent par là même comme des modèles de « lecture », voire même « d'écriture » de ces événements catastrophiques.

Les formes textuelles de ces paroles qui circulent autour de la maladie et de la réanimation s'inscrivent nécessairement, comme les autres, dans l'héritage

des histoires racontables, c'est-à-dire dans les traditions narratives. La notion d'intertextualité conceptualise justement ce rapport entre les différentes versions de son histoire présentée par un patient, d'une part, et d'autre part les multiples discours tenus avant lui et autour de lui sur le mal et la souffrance.

En d'autres termes, l'intertextualité décrit le processus de réordonnement des mots et d'appropriation des valeurs que ces mots convoient. Selon ce mode d'engendrement, « le texte redistribue la langue (il est le champ même de cette redistribution). Et l'une des voies de cette déconstruction reconstruction est de permuter des textes, des lambeaux qui ont existé ou existent autour du texte considéré, et finalement en lui : tout texte est un intertexte » [1, p. 370]. Tout récit, en particulier le récit de vie des patients, le « récit de soi malade », s'enlève sur le fond d'un texte palimpseste et se détache d'autres textes, actuels et antérieurs, sous de multiples formes et à tous les niveaux de son organisation, depuis ses modèles rythmiques jusqu'aux codifications lexicales, en passant par ses formes de composition, et aussi bien les modalités sociales qui président à la mise en scène de son énonciation, tout simplement par la façon de s'adresser au médecin ou au psychologue... pour en parler. Ce sont ces différents modes de transmission par « citation » qui président fondamentalement à l'engendrement du récit, l'intertexte étant justement, dit Barthes, le « champ général de formules anonymes, dont l'origine est rarement repérable, de citations inconscientes ou automatiques, données sans guillemets » [1, p. 370].

Clinique. Une situation de catastrophe somatique et son intertexte religieux

Ce sont de telles citations qu'on peut repérer dans la situation clinique suivante qui présente les difficultés d'une mère dont le fils se trouve dans le service de réanimation d'un centre de chirurgie hépato-biliaire. On pourra y reconnaître le filigrane de plusieurs de ces intertextes qui tout à la fois ordonnent le récit fait par cette dame de ce qui arrive à son fils (l'événement, ou l'accident qui l'amène en hospitalisation) et éclairent également, partiellement au moins, une décompensation anxieuse qu'elle a vécue au moment où son fils Mathieu a été victime d'un nouvel accident somatique, dont il n'a justement plus été possible de « faire l'histoire ».

Mathieu est alors âgé de 26 ans. Il a été transplanté à la suite d'une hépatite grave provoquée par une maladie rare dont *la cause est restée inconnue*. Il avait par ailleurs été victime, quelques années auparavant, d'une recto-colite hémor-

ragique, affection grave (considérée généralement comme psychosomatique), et dont le pronostic est parfois létal.

Les paragraphes qui suivent synthétisent les éléments d'un suivi qui a été mené par l'un des auteurs (psychologue clinicien) dans le service en période post-opératoire :

Une rencontre avec Mathieu a eu lieu juste après sa transplantation, et il ne paraissait pas se trouver alors en difficulté particulière. Il avait une force physique et une sorte de volontarisme assez étonnant, qui lui avaient permis notamment de faire une remontée post-opératoire très rapide. J'avais également croisé sa mère à une ou deux reprises, auprès du lit, mais sans proposer d'entretien ni recevoir de demande particulière.

Ce sont en fait certains propos de Mathieu, et son histoire médicale, plus que son état actuel, qui avaient motivé la proposition de renouveler le premier entretien. Il expliquait par exemple que « tout allait correctement » mais qu'il n'arrivait pas encore bien à « contrôler la stabilité des images » qui lui passaient par l'esprit. Il prétendait également que ce n'était pas du tout l'intervention médicale qui avait auparavant stoppé l'évolution de la recto-colite, mais sa « seule force » et sa « pure volonté de s'en sortir ». Et actuellement il pensait bien sûr « maîtriser la situation ».

Cinq jours après la transplantation, toujours dans la période réanimatoire, Mathieu est victime de la perforation d'un ulcère du duodénum et doit être réopéré d'urgence. Il avait donc physiquement assez bien surmonté la première épreuve, mais la seconde intervention l'a cette fois complètement laminé et a notablement compromis ses certitudes quant au pouvoir de contrôle de son esprit sur son corps.

La perspective de cette transplantation avait, semble-t-il, pu être abordée relativement sereinement par Mathieu et les membres de sa famille, mais c'est cet autre accident qui n'a pas été du tout supporté par sa mère, ceci bien qu'elle n'ait été prévenue qu'après la réussite de l'opération, qui a eu lieu à 3 heures du matin, et c'est ensuite qu'elle s'est effondrée dans une crise d'angoisse.

La rencontre avec la mère de Mathieu a lieu le matin même, dans un local des consultations externes, alors qu'elle s'est un peu ressaisie. L'entretien prend une forme finalement assez sobre qui se réduit à la communication « distanciée » d'une anamnèse présentée dans un style presque rédigé, relatée point par point selon une chronologie linéaire, chaque épisode particulier de l'histoire racontée étant assorti d'une sorte d'ouverture interprétative

(par ex., Mathieu a été placé à l'âge de 14 ans chez sa tante afin de pouvoir aller dans un lycée qui paraissait mieux lui convenir ; et elle ajoute : « c'était peut-être une erreur de faire passer une scolarisation avant son maintien dans la famille ? », etc.).

Pendant une heure la maman de Mathieu déroule un récit bien ordonné de ce qu'elle a « bien fait », de ce qu'elle a « mal fait », exposant la dimension « sacrificielle » de son existence, relativement à l'éducation de ses trois enfants, le sacrifice, peut-être « insuffisant », disait-elle, étant celui de l'abandon nécessaire de son statut de femme pour celui de « mère dévouée ». Le récit touche alors à sa fin, ce qui était prévisible par l'organisation chronologique qui amenait à l'épisode actuel de la réanimation, et cette dame termine assez brusquement sur cette interpellation : « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour le sauver ? » ... Je reste là, sans voix, à tous les sens du terme...

Ce qui a été ainsi présenté peut être compris comme une sorte de « discours de la faute », qui s'est traduit notamment par l'expression récurrente du sentiment d'être une « mauvaise mère », et qui a sans cesse été doublé par une sorte de demande d'absolution. Dans son esprit, ces différents accidents médicaux correspondent – à tort ou à raison – à des somatisations à répétition, et c'est *en ce sens* qu'elle a raconté l'un après l'autre les différents problèmes familiaux, notamment la dureté du père à l'égard de ses enfants, mettant en question bien sûr son rôle de mère, sa difficulté à se séparer de son dernier fils, etc. Et ces processus supposés de somatisation lui sont alors apparus comme la manifestation corporelle de la faute et du châtement, quelque chose de l'ordre d'une stigmatisation. En d'autres termes, cette culpabilité individuelle s'est manifestée de façon indissolublement liée à l'idée d'une responsabilité maternelle telle que la culture peut la déterminer par la figure d'une Mère idéale.

Un « intertexte psychanalytique » peut également être évoqué, dans cette mesure où il ne manque pas dans ce discours une allusion au fait de savoir si elle aurait suffisamment pu satisfaire sexuellement son mari pour expliquer l'absence de ce dernier dans la vie familiale. Et c'est cette « carence » qu'elle pressentait comme étant à l'origine des difficultés de Mathieu. Ce sont des bribes de la *vulgate* analytique, en termes de « libido bien tempérée », qui ont resurgi ici, mais qui ont également été redistribuées dans des sources plus clairement religieuses pour subvenir aux contenus et présider à la composition de cette histoire.

L'effroyable avait été pour cette dame la rechute, le tout dernier accident, celui qui avait occasionné une bouffée d'angoisse, accident à entendre précisé-

ment comme une re-*chute*, proprement irrationnelle, parce que justement non assignable dans l'ordre organisateur de son histoire, c'est-à-dire sans intertexte. Elle pensait qu'ils avaient tous *déjà* « expié », dans une histoire prenant sens comme un parcours qui s'étend entre Pêché et Rédemption, et cette expiation avait *déjà* touché la limite qu'un Pardon accordé avait tout de même dû imposer, à savoir la mort possible de son enfant, laquelle était effectivement inéluctable sans transplantation. Cette référence avait jusqu'alors permis à la mère de Mathieu de réinscrire l'excès du désordre corporel, et l'absurde de la maladie mortelle, dans l'ordre des *significations communes* sur le *mal*, sur l'*origine* de ce mal, sur d'éventuels *moyens* de s'en prémunir et surtout de nouer une tentative, ici mise en échec, d'en gérer la part excédante. Alors la question pour elle était de savoir *pourquoi* elle s'était vue imposer cette nouvelle « épreuve », cette péripiétie non prévue et proprement insensée, de la perforation de l'ulcère duodénal ?

Ces intertextes analytiques et religieux, transformés tout de même par cette lecture assez personnelle, ordonnent chacun pour leur part ce qu'il en est de la culpabilité maternelle – en lui assignant tout d'abord ce qu'il en est, devrait, ou pourrait être de cette responsabilité, de la nature de la « faute », et de la valeur de la « sanction ». On ne peut d'évidence réduire univoquement ce schéma narratif à une version purement individuelle d'un drame œdipien (si ceci peut avoir un sens) sans voir comment celui-ci prend figure dans les médiations d'un texte culturel qui lui offre ses signifiants. Ceux-ci sont plus que des simples mots, mais bien des structures représentatives qui rendent possible l'expression de sa souffrance, et il n'existe justement pas de discours littéral, transparent et directement énonçable de ces réalités extrêmes. Il n'existe ni langage ni situation d'entretien hors-cadre et non métaphoriques « du mal subi, souffert ou commis », ce qui vaut aussi bien dans le registre théorique où les concepts sont initialement, et parfois demeurent des images, qu'il s'agisse de lien, d'enveloppe, de tissu, de processus... ou de pulsion.

D'autres intertextes participent à la composition des versions possibles de l'histoire de Mathieu, par exemple le motif insistant du « *ça devait arriver* » – pour l'avant-dernier chapitre de l'histoire, la greffe – qui porte le vif du tragique racinien, à savoir que la fin est dans le commencement. C'est une expression du fatal, du destin, qui constitue d'ailleurs un thème récurrent chez beaucoup de patients pour lesquels l'idée d'accident somatique, de pur désordre (organique), reste proprement inconcevable, comme un chaos dont on dit parfois justement qu'il est « sans nom ».

La configuration de l'incoordonnable

« Sans nom », ce chaos renvoie à une violence pure, dont aucune explication, ni médicale, ni morale, ne peut contenir la dimension tragique, jusqu'à la question finale qui en appelle indissociablement à la santé et au salut dans la référence à la salvation². Dans le mouvement même où la narratrice en appelle à un *devoir-faire* après avoir décrit un agir bien intentionné, est mis en abyme le *pouvoir-faire* dont la déclinaison et la mise en échec scande l'ensemble du récit.

Là où le discours de la faute permettrait encore le salut dans le repentir à qui porte sa croix, « la révélation tragique nous enseigne l'immérité » comme l'écrit François Laplantine [15, p. 146]. Devant la répétition et la confusion du malheur, répétition inattendue, imprévisible, et échappant à la logique médicale comme à celle de la faute déjà expiée dans le premier acte, surgit la question du « pourquoi ». Une question abyssale, qui sous-tend et habite la sémantique religieuse de ce que le théologien Jean-Jacques Gourd désigne comme « l'incoordonnable » [11] : ce qui n'est ni prévisible en termes de causes efficientes, ni justifiable d'un point de vue moral... mais *dont on ne peut pas ne pas rechercher le sens*, décliné par exemple dans la mémoire occidentale sous les auspices de la malédiction aveugle des dieux grecs ou encore du destin des Romains : *fatum*, ce qui est dit, ce qui échappe à toute prise. Chaque souffrance injustifiable rejoue la scène tragique de la mise en échec du « moi purement organisateur et constructeur » [15, p. 146] : ce moi que tentait de convoquer le jeune homme à travers le registre de la volonté et de la maîtrise, et auquel sa mère entend également recourir en cherchant des causes « morales » efficientes.

Si la tragédie « nous présente *la douleur sans nom* », selon les mots de Schopenhauer [24, p. 495], ce qu'Aristote nomme le « *mythe* » donne un sens à l'absurde en configurant l'« agencement des faits » de l'histoire du protagoniste³. Le registre du mythe, qui selon les mots de Victor Goldschmidt, « parvient à rendre intelligible l'être par accident », est convoqué pour pouvoir simplement dire l'impensable ; il vient répondre à l'idée suivant laquelle « il semble bien que des faits de ce genre ne se produisent pas au hasard » [18, p. 264-265]. À ce titre, du point de vue narratif, l'intrigue de l'histoire qui raconte comment se déroule

2. Ce que Laurent Lemoine évoque comme le « tripode de guérison/salut/santé », qu'il invite à penser sous la « forme d'anneaux qui s'interpénètrent », qui peut aussi évoquer « les anneaux lacaniens du rsi (*Réel-Symbolique-Imaginaire*) » [16].

3. Ainsi, le mythe suivant lequel Œdipe tue son père et épouse sa mère donne-t-il le sens de la tragédie d'Œdipe roi.

la catastrophe, occupe bien ici la place de ce qu'Aristote appelle le *mythe* qui ouvre et clôt la tragédie. C'est à cette forme qu'en appelle Paul Ricœur pour rendre compte de la « configuration de la discordance » : quelles que soient les péripéties de l'histoire, le mythe exprime le destin que déroule toute tragédie.

Cette « synthèse concordante-discordante » que Paul Ricœur appelle la « mise en intrigue », introduit une intelligibilité à travers un ensemble de combinaisons par lesquelles les événements sont transformés en histoire [22]. Elle fait que « la contingence de l'événement contribue à la nécessité en quelque sorte rétroactive de l'histoire d'une vie, à quoi s'égale l'identité du personnage. Ainsi le hasard est-il transmué en destin » [21, p. 168]. Les tentatives pour agir sur les causes efficientes, quelle que soit leur nature, se trouvent alors submergées par le sentiment de l'impuissance et c'est un autre type de cause (celle qu'Aristote nomme la *cause finale*) qui place devant un questionnement abyssal : « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour le sauver ? »

Du récit de la maladie au récit de vie

Le contraste est saisissant, entre le « récit bien ordonné » qui se déroule sous l'apparence d'un rapport descriptif, médicalisé, chronologique, sobre, et l'intensité du désarroi et de l'espérance qui se formule dans la question finale. Dans cet écart s'exprime la disposition de la personne affectée par *l'épreuve*, dans sa dimension phénoménologique existentielle évoquée par Gabriel Marcel en son ambivalence constitutive qui conduit à « me replier sur moi-même ou m'ouvrir à autrui » [17, p. 104]. La sobriété initiale du récit manifeste le risque de prendre la parole, de s'exposer, avec ce que cela peut toujours avoir de redoutable, comme l'évoquent de façon universelle les mots de Michel Foucault dans les premières lignes de *L'Ordre du discours* qui valent pour l'auteur de tout texte : « Plutôt que de prendre la parole, j'aurais voulu être enveloppé par elle, et porté bien au-delà de tout commencement possible » [8]. Parce que cette épreuve ne peut être décrite mais seulement narrée, parce qu'elle rend compte d'une expérience insubstituable et ineffable, l'impossible récit de la maladie laisse place au récit de vie.

Avant de pouvoir devenir l'auteur de son histoire, la narratrice rend compte de l'histoire dans laquelle elle est prise, dans l'écho aux histoires qui configurent cette expérience inconcevable. La *configuration* dont il est ici question est encore en deçà, en amont de la *refiguration* évoquée par Paul Ricœur par laquelle le narrateur devient « l'auteur de son histoire », mais elle peut être entendue au sens plus originaire que lui donne Wilhelm Schapp suivant lequel l'expérience dont

on peut rendre compte ne peut jamais se dire, ni sans doute jamais s'éprouver, que sur le fond de notre « empêchement » dans des histoires [23].

Aucune représentation mentale d'un vécu ne procède seulement de la description photographique de faits qui pourrait relater la réalité. Le récit de soi ne peut se déployer que sur le fond d'un « nous », un nous qui vivons des histoires dans ce lieu tiers d'un langage qui nous précède et nous excède, à partir desquelles nous pouvons seulement reconfigurer ce que Paul Ricoeur évoque comme « notre expérience temporelle, confuse, informe, et à la limite, muette »⁴. Derrière la restitution formelle de l'expérience de la maladie, le récit de vie informe ce calvaire, en l'inscrivant dans une structure signifiante qui permet d'en exprimer la réalité vécue.

Le récit ici rapporté comporte deux dimensions qui renvoient aux horizons respectifs de la narratrice et de l'interprète dont la rencontre portera le texte vers son intelligibilité. Dépliant de façon chronologique la dimension épisodique du récit, à travers la succession inéluctable des événements racontés avec soin et de leur hypothétique coordination, le récit adressé veut « rendre compte », dans ce que Hans-Georg Gadamer nomme « l'explication-entente » qui caractérise le dialogue [9, p. 60]. Mais simultanément le récit qui « fait texte » et configure une temporalisation⁵ des événements dans une narration adressée, inscrit *l'incoordonnable* dans une certaine « logique », proposant au lecteur-auditeur une interprétation sous forme de question : ainsi, ces pistes ouvertes entre parenthèses, par exemple l'allusion à la scolarisation de Mathieu. En termes de théorie du texte, on dira avec Jérôme Bruner que le récit réussit à « subjonctiver la réalité » [2], en évoquant des possibilités plutôt que des certitudes, « *en explorant l'indétermination de la réalité et en incitant le lecteur à cette exploration* » selon les termes de Byron Good, à travers ce que l'anthropologue propose de désigner comme les éléments *subjonctivants* du récit de maladie [10, p. 314], c'est-à-dire ces hypothèses, ces pistes qui en appellent à la (nécessaire) interprétation du lecteur/auditeur. C'est une dimension constitutive du récit en tant qu'il est adressé au clinicien.

À ce titre, ce que la théorie littéraire nomme « la réponse du lecteur » prend ici une dimension majeure. Cette théorie de la « réponse du lecteur » vise à

4. C'est à partir de cette phrase de Paul Ricoeur que Jean Greisch entreprend de rechercher la fécondité propre de la notion d'empêchement proposée par Wilhelm Schapp [13].

5. Au sens où « la temporalisation consiste, comme son nom l'indique, à produire l'effet de sens "temporalité" et à transformer ainsi une organisation narrative en "histoire" » [12].

souligner que l'horizon *trans-subjectif* de la réception se dessine dans le texte lui-même. Elle inscrit la réception dans une « herméneutique de la question et de la réponse »⁶, situant dans le texte la question et dans sa lecture la réponse.

Or, précisément ici, la question adressée laisse « sans voix ». Et c'est précisément parce que le récit se déploie dans un échange qui ne relève pas du *dialogue* mais de l'*entretien* qu'il en appelle à une herméneutique. Cette lecture n'a pas pour objet de répondre à la question explicite de la patiente, mais à celle du clinicien qui cherche à entendre *ce que signifie* cette question.

Hans-Georg Gadamer distingue clairement l'entretien du dialogue : le dialogue repose sur un processus d'explication-entente, dans lequel on veut « comprendre non pas l'autre même comme individualité mais ce qu'il dit [...] ». Par contre, dès lors que nous voyons vraiment dans l'autre l'individualité, par exemple dans l'entretien thérapeutique [...], la situation de l'explication-entente cesse absolument » [9, p. 608]. Tout ce qui caractérise la compréhension dans le dialogue prend un tour propre au plan herméneutique, lorsqu'il s'agit, précisément, de la « compréhension de textes », et c'est bien ce dont il est question ici.

Le travail d'interprétation du clinicien à l'œuvre dans l'entretien est comparable à celui du traducteur. Si c'est « par l'entremise de l'interprète que le texte accède à la parole », c'est dans la *fusion d'horizons*, celui de la narratrice et celui de l'interprète, qu'accède à l'expression un horizon de sens partagé, dans la réalisation seconde du dialogue. Dans cette perspective, l'entretien peut alors être abordé comme un « dialogue herméneutique » selon l'expression employée par Hans-Georg Gadamer pour rendre compte de l'interprétation à l'œuvre dans la traduction, qui rend accessible et intelligible un texte. Cette histoire singulière peut alors se réaffilier à l'histoire humaine.

Du monde du texte au texte du monde

Le récit entendu comme texte ouvre l'auditeur au monde du narrateur, en déployant un horizon de sens partagé avec d'autres dans l'usage de réseaux sémantiques qui, bien que familiers, interpellent. C'est en faisant écho à d'autres textes issus de traditions dans lesquelles l'expérience individuelle vient s'inscrire à son insu, que le récit tire de la survenue d'une suite d'événements *a priori* hétérogènes, une « histoire sensée », structurée à travers des paradigmes

6. Cette théorie de la réception, qui fait du lecteur un protagoniste essentiel du sens du texte, a été développée par l'école littéraire de Constance, avec Hans Robert Jauss et Wolfgang Iser.

« issus d'une histoire sédimentée » qui retient toute l'attention de P. Ricœur dans la *Mimesis II* [20, p. 125-136].

Cette interaction du texte avec ceux qui l'ont précédé ouvre alors au « monde du texte », mais aussi au monde de la narratrice, ou plus précisément, à sa compréhension de sa situation (à son « *horizon* »).

Elle témoigne de manière exemplaire de ce que W. Schapp nomme « l'empêchement » dans des histoires : tout ce qui constitue le monde et l'expérience quotidienne (ce que Heidegger désigne sous le mot *Zuhandenenes* – littéralement, ce qui est « sous-la-main ») est toujours d'emblée inscrit dans des histoires. Pour reprendre les termes de Paul Ricœur, la « voie longue » de l'herméneutique (l'étude des textes) éclairerait alors en retour la « voie courte » d'une herméneutique ontologique (l'analytique existentielle). L'entente de l'écho de ces références dans le texte ouvre à la triple ekstase de la facticité d'un être jeté au monde (*Geworfenheit*), de la compréhension (*Verstehen*) et du projet (*Entwurf*) de l'être au monde.

Dans cette double perspective épistémologique et existentielle, l'interprétation du récit inscrit le rapport du psychique et de son environnement dans ce qui constitue un monde, c'est-à-dire dans cet horizon de sens collectif, cet enchevêtrement des histoires dans lesquelles nous sommes pris, sur le fond duquel s'inscrit toute expérience, et en particulier celle de faits défiant toute cohérence et tout fondement dans une « factuelité ». La notion gadamérienne de la « fusion des horizons » signifie, nous dit Jean Grondin, qu'« il s'agit d'entendre une vérité plus ancienne encore que cette adéquation entre l'intelligence et la chose. » Cette vérité plus originaire, et qui rend possible l'adéquation de la pensée et de la chose, est « celle du langage lui-même [...] dans sa capacité de découvrer des choses elles-mêmes ». C'est en ce sens que l'herméneutique de la fusion des horizons se veut une phénoménologie, « une découverte du mode de donation des choses et des choses telles qu'elles se donnent. » [14]. La compréhension du langage dans cette capacité de « découvrer » n'est possible que parce que le lecteur ne se trouve pas seulement « face à un sens », mais qu'il en est d'abord « saisi ». Si la compréhension, ancrée dans la *fusion des horizons* et, plus originairement d'un *empêchement* commun, conditionne dans cette perspective toute *explication*⁷, l'explication, où il s'agit pour le lecteur « de se tenir dans le lieu du texte et dans la clôture de ce lieu », permet, dit encore Paul Ricœur, de « comprendre mieux ».

7. P. Ricoeur précise lui aussi que « l'explication n'est pas première mais seconde par rapport à la compréhension » [18, p. 6].

Encore faut-il en effet qu'un tiers puisse entendre mais aussi lire ce qui est ici partageable, attester des histoires communes immémoriales qui habitent cette expérience solitaire, pour qu'ici l'auteur du texte n'en demeure pas prisonnier. C'est dans l'acte de lecture que l'auditeur-lecteur assume une fonction de médiation entre la *préfiguration* des événements racontés et la *refiguration* de l'histoire [22, p. 146]. C'est par la médiation de ce tiers que la narratrice pourrait se distancer du rôle ou du caractère qu'elle s'attribue dans cette histoire, dans une reconquête, à travers cette relecture, de son ipséité – à laquelle renvoie l'« identité narrative » dont parle Paul Ricœur.

En substance : le texte établi par cette patiente est alors apparu, si l'on peut dire, comme presque clos – *insuffisant* dans ce « presque », et *excessif* dans cette « clôture ».

Conclusion

Face à ceci, du point de vue du soin psychique, et compte tenu du contexte hospitalier, il s'est fondamentalement agi ici de permettre à la patiente de réaffilier son désarroi dans un autre intertexte, ou du moins dans une strate plus différenciée des textes interpellés (religieux, tragique, analytique) : c'est-à-dire déplacer leur organisation vers un entre-deux, un champ intermédiaire du pensable, et les rendre à cette patiente pour qu'elle puisse remodeler cette configuration qui ne suffisait plus à tenir le sens qu'elle avait jusqu'alors donné à ces catastrophes médicales, ce qui revient en quelque sorte à tenter de faire apparaître *autrement* l'énonciatrice dans l'énoncé. Faire « la part des choses » a donc tout d'abord consisté à mettre les choses à part, c'est-à-dire en un premier temps faire se desceller cette presque totale adhésion à ce qui n'a finalement pas pu entièrement contenir et lier cette nouvelle catastrophe (la perforation de l'ulcère), laquelle a surgi comme « une de trop ».

Parler de texte (narratif) à propos des paroles et récits que les patients donnent d'eux-mêmes et de leur maladie, c'est donc une manière d'insister sur une certaine autonomie de ce discours par rapport à celui qui l'énonce (le sujet de l'énonciation), à ce qu'il raconte (le référent), et ses liens avec les autres récits (l'intertexte). Et l'on conçoit dès lors mieux le texte du récit non pas comme un « produit fini » (qui serait l'histoire racontée) mais comme une *pratique signifiante*, comme un mouvement de (*re-*)*composition*, de (*re-*)*structuration*, ressortissant tout à la fois à un *travail psychique* (ce que J.-L. Pédinielli nomme le « travail de la maladie » [19]) et à un *jeu de langage*, c'est-à-dire non

pas tant un système clos de signes à déchiffrer dans l'après-coup du discours, mais un ensemble de traces mobiles qui se (re-)distribuent dans la parole vive.

C'est en quoi le travail thérapeutique peut se donner un enjeu essentiel consistant à porter la rencontre entre le texte et son sujet dans l'assomption renouvelée d'un Je qui se projette et se reconnaît (pour un temps du moins) dans ces énoncés *identifiants*. Ces énoncés ont pris pour la patiente la forme de son histoire passée et de son histoire possible, future, en une sorte de stade du miroir verbal traversé et répété après-coup, où l'autre, le thérapeute, exerce cette fonction de reconnaissance des morceaux dispersés (que sont les fragments de discours, les résurgences intertextuelles, c'est-à-dire ces citations sans guillemets dont parle Barthes). Il est ainsi permis au sujet de saisir ce qui, dans ces pièces détachées, garantirait (provisoirement) une forme sensée et contenante.

Ni le patient et sa souffrance, ni le thérapeute et sa pratique, ne peuvent donc se penser et se dire hors de cette histoire (et préciser qu'elle est culturelle et institutionnelle ferait pléonasme), la « tradition » fournissant les valeurs et les *formes* (discursives) qui déterminent les ressorts de son intelligibilité.

La souffrance, dès qu'elle tente d'entrer dans le jeu d'une sémiose, s'empare d'un mode discursif culturellement modelé. Et produire du sens pour le patient peut consister, initialement, à circonscrire une position singulière par rapport à ces jeux de signifiants culturels. C'est pourquoi parler d'intertexte permet ici de s'inscrire dans la matérialité d'une logique de *filiation* des représentations portant sur la souffrance psychique et sa prise en charge, en insistant sur la *consistance textuelle* de ces représentations, sur la *texture* des mots et également des images qui disposent une place au sujet.

Références

1. Barthes R. 1995. Théorie du texte. *Encyclopaedia Universalis* 22.
2. Bruner J. 1986. *Actual minds, possible worlds*. Cambridge, MA : Harvard University Press.
3. Charon R. 2021. Expérience, récit et soin. Les fondements sociaux et conceptuels de la médecine narrative. *Médecine et philosophie* 5 : 5-10.
4. DelVecchio Good M.-J. 1984. *American Medicine : The Quest for Competence*. Berkeley-Los Angeles-Londres : University of California Press, p. 178.
5. Dubasque M. 2022. Médecine narrative, entre concept et pratique clinique : de l'objet-récit à l'effacement de « l'être-à-dire » ? *Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences* 20(1) : 73-86.

6. Ferry-Danini J. 2020. La médecine narrative face à l'impossible singularité des récits. *Lato Sensu. Revue de la Société de philosophie des sciences* 7 (2) : 1-6.
7. Fulford K. W. M., Peile E., Heidi C. 2017. *La clinique fondée sur les valeurs. De la science aux personnes*. Paris : Doin.
8. Foucault M. 1971. *L'ordre du discours (leçon inaugurale du Collège de France prononcée le 2 décembre 1970)*. Paris : Gallimard.
9. Gadamer H.-G. 1996. *Vérité et Méthode – Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique*. Paris : Seuil.
10. Good B. 1998. *Comment faire de l'anthropologie médicale ? Médecine, rationalité et vécu* [1994]. Le Plessis-Robinson : Institut Synthélabo.
11. Gourd J.-J. 1943. *Philosophie de la religion*. Paris : F. Alcan.
12. Greimas A. J., Courtes J. (eds.). 1979. *Sémiotique : Dictionnaire raisonné de la théorie du langage (Langue, Linguistique, Communication)*. Paris : Hachette.
13. Greisch J. 1990. Empêchement et intrigue : une phénoménologie pure de la narrativité est-elle concevable ? *Études phénoménologiques* 11 : 41-83.
14. Grondin J. 2005. La fusion des horizons - La version gadamérienne de l'*adaequatio rei et intellectus* ? *Archives de philosophie* 68 : 401-418.
15. Laplantine F. 1976. *La philosophie et la violence*. Paris : PUF.
16. Lemoine L. 2011. La guérison entre salut et santé : la nouvelle donne de l'Église et du monde. *Revue d'éthique et de théologie morale* 264(2) : 98-107.
17. Marcel G. 1940. *Du refus à l'invocation*. Paris : Gallimard.
18. Goldschmidt V. 1982. *Temps physique et temps tragique chez Aristote : Commentaire sur le Quatrième livre de la Physique (10-14) et sur la Poétique*. Paris : Vrin.
19. Pedinielli J.-L. 1987. Le travail de la maladie. *Psychologie médicale* 19(7) : 1049-1052.
20. Ricœur P. 1983. *Temps et récit, I. L'intrigue et le récit historique*. Paris : Seuil.
21. Ricœur P. 1985. *Temps et récit 3, Le Temps raconté*. Paris : Seuil.
22. Ricœur P. 1986. *Du texte à l'action, Essais d'herméneutique II*. Paris : Seuil.
23. Schapp W. 1992. *Empêtrés dans des histoires. L'être de l'homme et de la chose* [1953], Paris : Éd. du Cerf.
24. Schopenhauer A. 2014. *Le monde comme volonté et représentation* [1819/1844]. Paris : PUF.